Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 4° andar - Bairro: Exposição - CEP: 95020190 - Fone: (54) 3039-9081 - Email: frcaxsul5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5011543-88.2021.8.21.0010/RS

AUTOR: ZAUDIR FRANCISCO TOMAZZONI

RÉU: PRO SALUTE -SERVICOS PARA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos etc.

ZAUDIR FRANCISCO TOMAZZONI, qualificada na inicial, por seu procurador, ingressou com ação de obrigação de fazer contra **PRO SALUTE -SERVIÇOS PARA A SAÚDE LTDA.** também qualificada.

Narrou ser beneficiário do plano privado de assistência à saúde Global Padrão comercializado pela ré desde 01/05/1992, cujo contrato foi regulamentado em 23/07/1999. Sustentou ser portador da doença púrpura trombocitopênica idiopática (CID 10 – D69.3), diagnosticado no ano de 2020, pelo Dr. Tiago Daltoé, CRM 27471. Inicialmente, o Dr. Tiago receitou o medicamento Prednisona para tratar a referida doença, contudo, em razão da necessidade do uso de alta dosagem deste fármaco, a diabete do autor restou prejudicada ocasionando a piora de sua vasculopatia e motivou "mais de uma intervenção cirúrgica" (sic). Diante dos efeitos colaterais do tratamento com Prednisona na saúde do Autor, o Dr. Tiago indicou novo tratamento com a utilização do medicamento Eltrombopague Olamina 50mg (Revolade), o qual foi solicitado junto à ré. Afirmou que a ré negou a cobertura contratual do tratamento sob a justificativa de que "a medicação não está inclusa no Rol da ANS em vigor, não sendo de cobertura das Operadoras conforme Agência Nacional de Saúde - ANS"(sic) e que a "RN 465 de 24 de fevereiro de 2021, a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS) não demonstrou evidência científica sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento"(sic). Todavia, tais justificativas não existem na referida RN 465 da ANS ou anexos. Alegou que a negativa de cobertura contratual é abusiva posto que o tratamento solicitado pelo médico assistente é essencial para a melhora do quadro clínico do autor, bem como o plano de saúde não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Destacou que a ré não ofereceu tratamento igualmente eficaz para o tratamento da doença. Discorreu sobre o direito aplicável. Invocou a incidência do CDC. Requereu a concessão de tutela de urgência, para que a ré forneça o medicamento Eltrombopague Olamina (Revolade 50 mg), conforme prescrição médica, sob pena de aplicação de multa diária. Pediu a condenação da ré à cobertura integral do tratamento com utilização da medicação Eltrombopague Olamina 50 mg (Revolade) indicados pelo médico-assistente. Ao final, pediu a procedência da ação. Atribuiu à ré os ônus sucumbenciais. Deu à causa o valor de R$10.525,00. Juntou documentos (Evento1).

Foi deferida a AJG, bem como a tutela de urgência (Evento 3).

Citada, a demandada contestou (Evento 12). Preliminarmente, impugnou a concessão do benefício da AJG. Informou o cumprimento da liminar. Sustentou que o fornecimento do medicamento Eltrombopague Olamina (Revolade 50 mg) prescrito ao demandante pelo seu médico assistente, não está previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde em vigor, assim como no contrato de plano de saúde firmado entre as partes. Salientou que o próprio SUS (Sistema Único de Saúde) não incorporou o medicamento Eltrombopague Olamina (Revolade 50 mg) no sistema, devido a não aprovação da CONITEC. Disse que não se contesta o fato de que o médico assistente é a pessoa mais competente para definir o tratamento médico a seu paciente, o que se quer deixar claro é que o tratamento médico que extrapola as obrigações contratuais não pode ser exigido do plano de saúde, quando este não se obrigou a isto e a lei a que se submetem os planos, assim não determina. Destacou que o contrato firmado entre as partes é claro ao excluir procedimentos não previstos no rol e em suas diretrizes de utilização. Discorreu sobre os contratos de plano de saúde. Pediu a improcedência da ação, com condenação do autor aos ônus sucumbenciais; e a revogação da tutela concedida. Juntou documentos.

Houve réplica (Evento 15).

Acolhida a preliminar, foi revogada a AJG do autor (Evento 17).

Foi deferida a AJG em Agravo de Instrumento (Evento 50).

Intimadas as partes quanto ao interesse na produção de provas, apenas o autor juntou documentos (Evento 55), de tudo tendo vista o demandado (Evento 76).

Remetido o processo ao CEJUSC, não houve acordo (Evento 80).

Intimado o demandado para indexar o contrato do plano de saúde que o autor está vinculado, contendo as cláusulas gerais (PLANO INDIVIDUAL), conforme termo aditivo do Evento 12 - CONTR4 (Evento 86), o réu disse que o contrato foi integralmente juntado com a contestação (Evento 91).

Com vista, o autor requereu a conversão do ônus da prova (Evento 94).

Foi deferida a inversão do ônus da prova e intimada a para ré a juntar contrato e demais documentos objeto da lide (Evento 96).

O demandado reiterou a manifestação anterior (Evento 100).

Relatei. Decido.

Cabível o julgamento antecipado do feito no estado em que se encontra, na hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que as partes não postularam outras provas.

A pretensão da parte autora é de que a ré seja obrigada a fornecer o medicamento Eltrombopague Olamina 50mg (Revolade), uma vez que é portador da doença púrpura trombocitopênica idiopática (CID 10 – D69.3), conforme indicado pelo médico assistente.

A demandada, por sua vez, referiu que o fármaco não está previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde em vigor, assim como no contrato de plano de saúde firmado entre as partes. Salientou que o próprio SUS (Sistema Único de Saúde) não incorporou o medicamento Eltrombopague Olamina (Revolade 50 mg) no sistema, devido a não aprovação da CONITEC.

Gize-se que os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificando tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:

Súmula 469. **Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde**.

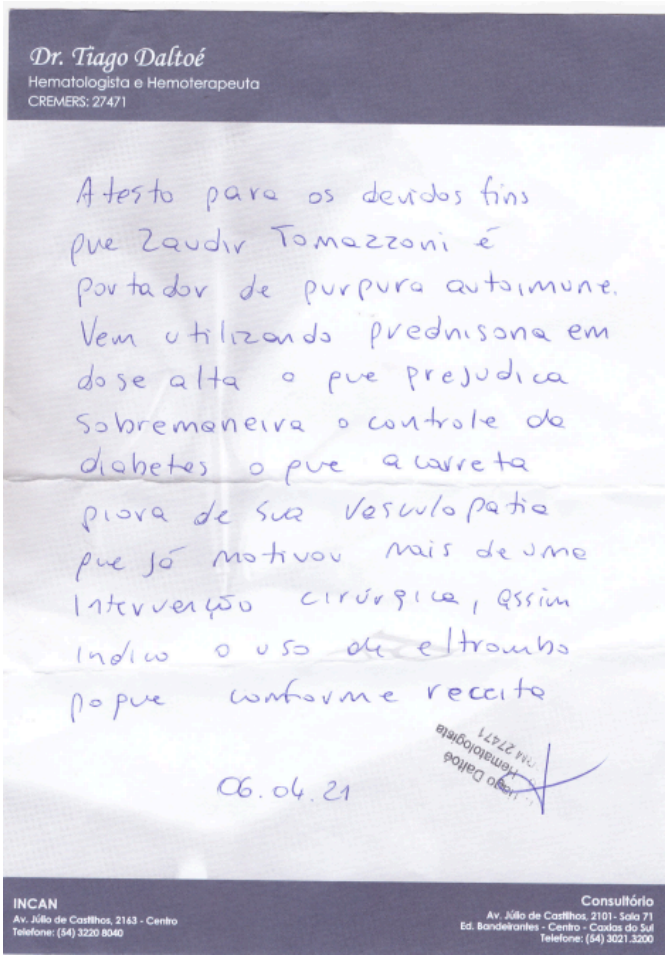
Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Igualmente, deve incidir o disposto no art.51, IV, §1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Considera-se também exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

Além disso, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

O laudo médico do assistente, Dr. Tiago Daltoé (Evento 1, ATESTMED8) assim atesta:



Dr. Tiago Daltoé
Hematologista e Hemoterapeuta
CREMERS: 27471

Atesto para os devidos fins que Zaudir Tomazzoni é portador de purpura autoimune. Vem utilizando prednisona em dose alta o que prejudica sobremaneira o controle do diabetes o que acarreta piora de sua vasculopatia que já motivou mais de uma intervenção cirúrgica, assim indico o uso de eltrombopa que conforme receita

06.04.21

Tiago Daltoé
Hematologista
CRM 27471

INCAN
Av. Júlio de Castilhos, 2163 - Centro
Telefone: (54) 3220 8040

Consultório
Av. Júlio de Castilhos, 2101 - Sala 71
Ed. Bandeirantes - Centro - Caxias do Sul
Telefone: (54) 3021.3200

De acordo com o documento do Evento 1, DECL7, a ré negou a cobertura do medicamento, sob o argumento de que a medicação não está no rol da ANS em vigor e, além disso, conforme RN nº 465 de 24-02-2021, a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS) não demonstrou evidência científica sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento.

Conforme noticiado pelo autor, atualmente o medicamento encontra-se recomendado pela CONITEC, conforme Portaria nº 72, de 11 de dezembro de 2018 (Evento 15 - OUT3).

Ao contrário do que foi alegado pelo plano de saúde na petição do Evento 91, o termo aditivo indexado no Evento 12, CONTR4, firmado em 23-7-1999, demonstra que o autor está vinculado ao plano de saúde denominado "Plano Individual" adaptado à Lei n. 9.656/1998, cujas cláusulas gerais não foram apresentadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A CONTRANTE mantém junto a CONTRATADA contrato de prestação de serviços de assistência médica e hospitalar, dentro das cláusulas gerais do contrato supra descrito e ora aditado, cuja vigência se encontra ao abrigo da Lei 9.656/98 e Resoluções do CONSU, sendo a CONTRATANTE e seus dependentes beneficiários dos serviços mantidos pela CONTRATADA.

De acordo com a Lei n. 9.656/1998:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: **(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)**

[...]

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; **(Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)**

[...]

§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. **(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)**

[...]

Ou seja, os planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamentos para uso domiciliar, exceto os antineoplásicos orais ou medicamentos utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar.

Ao julgar os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.886.929 - SP (2020/0191677-6), o STJ firmou o seguinte entendimento:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO.

1. A Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3º sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o art. 4º, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, Documento: 160376796 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 03/08/2022 Página 1 de 7 Superior Tribunal de Justiça de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades.

2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 quanto do art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000 que é atribuição dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n. 9.656/1998, o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas.

3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n. 439/2018, ora substituída pela Resolução Normativa ANS n. 470/2021, ambas dispondo sobre o rito processual de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e quaisquer coberturas vindicadas

pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de 2 de setembro de 2021, incluiu o art. 10-D, § 3º, I, II e III, na Lei 9.656/1998 para estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4º do art. 10, devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando couber; e III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar.

4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável Documento: 160376796 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 03/08/2022 Página 2 de 7 Superior Tribunal de Justiça economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população.

5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp n. 988.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, DJe de 14/11/2018). Dessa maneira, ciente de que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação contratual.

6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem mesmo integra a lide. A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte litigante, analisa os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em mira a universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior número possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício profissional da Medicina, dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a elaboração do Rol.

7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do Estado em não expor o Documento: 160376796 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 03/08/2022 Página 3 de 7 Superior Tribunal de Justiça consumidor e paciente a prescrições que não encontrem respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que virem reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de fornecedores de produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica suplementar.

8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo, ignora que é ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, assim como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção, favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica, com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no equilíbrio atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e para o incremento do reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos, no que tange à segurança dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com esse entendimento jurisprudencial, reflexamente teria sua demanda aumentada.

9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021). Ademais, assentaram que não é papel do Judiciário promover a substituição técnica por outra concepção defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no REsp n. 1.823.636/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Documento: 160376796 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 03/08/2022 Página 4 de 7 Superior Tribunal de Justiça Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021).

10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma, **a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima.** Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais.

11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: **1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Documento: 160376796 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 03/08/2022 Página 5 de 7 Superior Tribunal de Justiça Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.**

12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos – o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos.

13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado.

14. Embargos de divergência a que se nega provimento. **[Grifei].**

Consoante o entendimento firmado pelo STJ, em regra, o Rol da ANS é taxativo, não sendo a operadora do plano de saúde obrigada a arcar com tratamento não constante no Rol da ANS, se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; podendo, porém, ser admitida, excepcionalmente, o uso de fármaco não previsto no rol, desde que evidenciada as seguintes hipóteses:

1. Não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

2. Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

3. Haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e

4. Seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Documento: 160376796 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 03/08/2022 Página 5 de 7 Superior Tribunal de Justiça Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

No caso concreto, embora haja prescrição médica, não há prova técnica que demonstre a necessidade do uso do fármaco pelo autor, devendo, portanto, ser observado o Rol taxativo da ANS.

Dessa forma, não se mostra abusiva a negativa da operadora do plano de saúde no fornecimento do medicamento, não previsto no rol da ANS, eis que amparado pela legislação vigente e entendimento jurisprudencial

Por conseguinte, encaminha-se a improcedência da ação.

Isso posto, **JULGO IMPROCEDENTE** a ação de obrigação de fazer, revogando a decisão que antecipou a tutela e atribuindo à autora, **ZAUDIR FRANCISCO TOMAZZONI,** o pagamento da taxa única e despesas processuais, mais honorários ao procurador da parte demandada, que fixo no valor de R$1.800,00, corrigido pelo IPCA a contar desta data, e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado da decisão, respeitados os critérios definidos no art. 85, §§ 8º e 16, do CPC.

A exigibilidade da sucumbência fica suspensa em relação à parte demandante, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão de estar litigando sob o manto da gratuidade da justiça.

Intimem-se. Havendo recurso, após processado, remetam-se ao TJRS. Caso contrário, arquivem-se.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO PAULO BERNSTEIN, Juiz de Direito**, em 6/9/2022, às 13:42:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10019210100v41** e o código CRC **acffd637**.